

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 1 Hygienemaßnahmen beim Auftreten multiresistenter Krankheitserreger (MRE) (z.B. Methicillinresistenter Staphylococcus aureus - MRSA, multiresistente gramnegative Erreger wie ESBL) und gemäß „Maßnahmeplan beim Auftreten von MRSA“, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Teil 3B	

Anlage 1

Hygienemaßnahmen beim Auftreten multiresistenter Krankheitserreger (MRE) (z.B. Methicillinresistenter Staphylococcus aureus - MRSA, multiresistente gramnegative Erreger wie ESBL)

Patienten mit einer Infektion mit einem multiresistenten Krankheitserreger werden in der Regel nicht bis zur Heilung ihrer Grundkrankheit im Krankenhaus behandelt. Zum Zeitpunkt der Entlassung aus der stationären Behandlung kann mitunter noch eine Besiedlung (Kolonisation), z.B. mit MRSA (Nasen-Rachenraum, Wundflächen), vorliegen. Eine begonnene Therapie sollte unbedingt im häuslichen Bereich weitergeführt und beendet werden. Normale soziale Kontakte unter Familienangehörigen stellen unter diesen Umständen kein Risiko dar. Dagegen besteht eine Gefährdung für Personen mit großflächigen Wunden, nässenden Ekzemen, oder für Abwehr- und Immungeschwächte, auf die u. U. multi-resistente Erreger übertragen werden können, wenn Hygienemängel in der Pflege bestehen. Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste müssen zur Problematik der multiresistenten Erreger **umfassend** und **aktuell** geschult sein. Die Festlegungen regionaler MRE-Netzwerke sind zu berücksichtigen, z.B. die Verwendung von MRE-Überleitungs-/ Übergabebögen.

Wichtigste und wirksamste Maßnahme zur Prävention von multiresistenten Keimen ist die Händehygiene:

- Das Tragen von Schutzkleidung (möglichst Einmalschutzkleidung) ist bei allen Pflegemaßnahmen notwendig, bei allen Tätigkeiten am und mit dem zu Pflegenden.
- Das Tragen von Einmalschutzhandschuhen ist notwendig, wenn die Gefahr des Kontakts mit Ausscheidungen oder Blut bzw. mit multiresistenten Erregern besiedelten Körperoberflächen oder Gegenständen besteht.
- Nach Ablegen der Einmalschutzhandschuhe ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich.
- Beim Verlassen des Zimmers ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.
- Gegenstände und Flächen sind bei Kontamination einer Wischdesinfektion zu unterziehen.
- Entsorgungsgüter sind sofort in geeigneten verschließbaren Plastiksäcken/-tüten dem Müll beizugeben; spitze und scharfe Gegenstände, von denen eine Verletzungsgefahr ausgehen kann, sind in durchstichsicheren Behältnissen verpackt in den Müll zu geben.
- Sofern nicht grundsätzlich Einwegmaterial als Schutzkleidung getragen wird, ist textile Schutzkleidung mit einem desinfizierenden Waschverfahren zu waschen (s. 4.2).
- Bei der Pflege eines MRE-kolonisierten/-infizierten Patienten sollte immer ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen werden, um durch unbewussten Hand-Mund-Nasenkontakt eine Eigenkontamination zu verhindern.
- Bei der Gefahr der Erregerübertragung durch Aerosole, z.B. bei der Tracheostomapflege, sollte in Abhängigkeit der Risikogruppenzuordnung des Erregers mindestens ein partikelfiltrierender Atemschutz der Klasse 1 (FFP1-Halbmaske) oder ein eng anliegender,

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 1 Hygienemaßnahmen beim Auftreten multiresistenter Krankheitserreger (MRE) (z.B. Methicillinresistenter Staphylococcus aureus - MRSA, multiresistente gramnegative Erreger wie ESBL) und gemäß „Maßnahmeplan beim Auftreten von MRSA“, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Teil 3B	

mehrlagiger und im Nasenbereich modellierbarer Mund-Nasen-Schutz in FFP1-Qualität getragen werden (die herkömmliche OP-Maske ist hierfür nicht geeignet).

Sollte eine Sanierung aus Gründen der Infektionsprävention im Rahmen der häuslichen Pflege notwendig sein und keine sanierungshemmenden Faktoren vorliegen, sind alle dazu erforderlichen Maßnahmen mit dem behandelnden Hausarzt abzusprechen und sorgfältig durchzuführen:

Zur Verhinderung von Übertragungen des Erregers auf andere Menschen ist eine konsequente Händehygiene zu beachten: z.B. Händewaschen nach dem Toilettengang und nach Husten, Niesen oder Naseputzen.

Sanierungen werden mit dem Ziel durchgeführt, den Erreger vollständig zu beseitigen.

Alle Maßnahmen sind konsequent über 5 bis 7 Tage durchzuführen:

- Dekontamination des Nasenraumes mit geeigneten Präparaten
- Dekontamination der Haut durch tägliche Ganzkörperwaschung unter konsequenter Einbeziehung des Kopfhaares, anschließend Waschlappen und Handtücher wechseln
- infizierte Hautstellen täglich behandeln
- antiseptische Behandlung der Mundhöhle und des Rachenraumes durch Austupfen, Spülen oder Gurgeln mit Antiseptika
- Desinfektion persönlicher Gegenstände (z.B. Zahnprothese, Brille, Haarbürste, Rasierapparat).
- Zum Zähneputzen sind Einmalzahnbürsten oder das Einlegen der Zahnbürste in ein Schleimhautantiseptikum bis zum nächsten Zähneputzen zu empfehlen.
- täglicher Wäschewechsel (Leib- und Bettwäsche) vor der Wiederbenutzung nach erfolgter Waschung

Ist eine Verlegung mit einem Krankentransport notwendig, so ist die Zieleinrichtung (Krankenhaus, Pflegeheim, Reha-Klinik etc.) und der Transportdienst hierüber zu informieren.

Die Feststellung von MRSA-Erregern ist meldepflichtig. Die Information hat von blutuntersuchenden Laboren an das jeweilige Gesundheitsamt zu erfolgen.

Kostentragung von MRSA/MRE Untersuchungen (Kassenärztliche Bundesvereinigung 2012)

Zielgruppe: Für diese Patienten gilt die Vereinbarung

Der MRSA-Risikopatient muss in den letzten sechs Monaten stationär behandelt worden sein (mindestens vier zusammenhängende Tage) **und zusätzlich** die folgenden Risikokriterien erfüllen:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 1 Hygienemaßnahmen beim Auftreten multiresistenter Krank- heitserreger (MRE) (z.B. Methicillinresistenter Staphylococcus aureus - MRSA, multiresistente gramnegative Erreger wie ESBL) und gemäß „Maßnahmeplan beim Auftreten von MRSA“, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Teil 3B	

- positiver MRSA-Nachweis in der Anamnese und/oder zwei oder mehr der nachfolgenden Risikofaktoren:
- chronische Pflegebedürftigkeit (mindestens Stufe 1),
- Antibiotikatherapie in den zurückliegenden sechs Monaten,
- liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde),
- Dialysepflicht,
- Hautulkus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteilinfektionen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA